



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رابعياً : داليا قطب محمود قطب عباده

المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : مدينه نصر الاول العنوان : //

رقم البطاقة : 27805101600947 رقم التليفون : 01202934530 تاريخ تسجيل الإستمارة : 28-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 10-05-1978 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....) المقر بما فيه التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي بروتوكول علاج كيماوي خط ثاني للورم المتناثر (Platinum +Gemcitabine) [14245] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة. تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: داليا قطب محمود قطب عباده National ID: 27805101600947	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Platinum plus gemcitabine chemotherapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

داليا

قطب محمود قطب عباده

٧ عمارات العبور - صلاح سالم

مدينة نصر أول - القاهرة

١٩٧٨/٠٥

LZ1116339

٢٧٨.٥١.١٦.٠٩.٤٧

١٢٢٧٤١٠٩١٢

١-٣٣٣٢٤٩٣



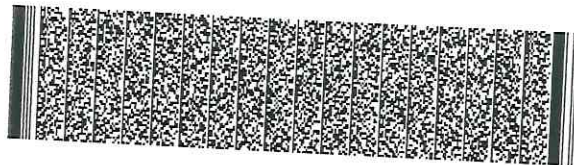
٢٠٢٦/٠٩ ٢٧٨.٥١.١٦.٠٩.٤٧

حاصله على دبلوم تجاره

متزوجة أنثى مسلمة

محمد احمد بدوى سليمان دهمه

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠٩/١٨



Dr.

Elia Anis Ishak

M. Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology , USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.

Shady Elia Anis

M. Sc. MD Pathology , Ass. Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow , Mass General Hospital , Harvard , USA
Member , United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : داليا قطب محمود قطب عباده

Age : 47 Y : 6 M : 1 D

Referred By Prof. Dr. : وليد فرج

Clinical Diagnosis : Right breast mass

Nature of Specimen : Surgical excision and lymph node clearance

Receiving Date : 2025/11/26

Analysis ID : 1012700

Gender : Female

Patient ID : 715910

PATHOLOGY REPORT

Gross :

Two specimens were received;

1- Specimen received distorted undesignated opened, consists of a piece of breast tissue measured 6.6x6x5 cm, no skin covering. Cut section revealed firm gritty tumor tissue with ill defined borders measured 2.1x1.8x1.1 cm.

Surgical margins are free, the least surgical margin measured 0.1 cm.

2- Fibrofatty tissue measured 3.5x3x2.5 cm entangling multiple nodules, largest measured 2.5x1x0.5 cm.

Micronscopic :

Sections examined from the specimen (1) received revealed breast tissue showing tumour tissue formed of irregular groups of malignant ductal cells showing moderate nuclear pleomorphism, hyperchromasia.

There is poor attempt at tubular formation.

The mitotic index is high.

There is moderate desmoplasia.

There is peritumoural lymphocytic infiltration around 10 %.

Lympho-vascular space invasion present.

Perineural invasion is absent

No intraductal component .

The surrounding breast tissue showed adenosis.

Surgical margins are free. Free skeletal muscle seen.

Sections examined from the specimen (2) revealed NO metastatic deposits in 10 nodes.

There are two malignant masses in the axillary fat showing same features as the tumor above measured 1.4 cm and 0.6 cm.



عمارة رمسيس - بلوك أ - ميدان رمسيس - الدور السادس و السابع
تليفون : ٢٥٧٤٤٧٤٢ - ٢٥٧٧٣٢٥٣ - ٢٥٧٩٠٩٣٥ - ٠١٢٨٧٠٠٥٢١٧

1/1

Dr.
Elia Anis Ishak
M. Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology , USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.
Shady Elia Anis
M. Sc. MD Pathology , Ass. Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow , Mass General Hospital , Harvard , USA
Member , United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : داليا قطب محمود قطب عباده

Analysis ID : 1012700

Age : 47 Y : 6 M : 1 D

Gender : Female

Referred By Prof. Dr. : وليد فرج

Clinical Diagnosis : Right breast mass

Nature of Specimen : Surgical excision and lymph node clearance

Receiving Date : 2025/11/26

Patient ID : 715910

PATHOLOGY REPORT

Diagnosis :

Right breast mass, Surgical excision and lymph node clearance
INFILTRATING DUCT CARCINOMA GRADE III, NO INTRADUCTAL COMPONENT .
FREE SURGICAL MARGINS, NO AXILLARY LYMPH NODE METASTASIS , L.N. 0 / 10,
TWO AXILLARY MASSES, INFILTRATING DUCT CARCINOMA, GRADE III
Stage pT2 pN0.

Prof. Dr. Shady Elia Anis

Prof. Dr. Elia Anis Ishak

Shady Elia

Elia Anis



This report is electronically signed , any abrasion or modification would render it void .

2/2

عمارة رمسيس - بلوك أ - ميدان رمسيس - الدور السادس و السابع
تليفون : ٢٥٧٤٤٧٤٢ - ٢٥٧٧٣٢٥٣ - ٢٥٧٩٠٩٣٥ - ٢٥٧٩٠٩٣٥ - ١٢٨٧٠٠٥٣١٧

Dr.

Elia Anis Ishak

Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology, Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology, USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.

Shady Elia Anis

M. Sc. MD Pathology, Ass. Prof. of Pathology, Cairo University
Fellow, Mass General Hospital, Harvard, USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : داليا قطب محمود قطب عباده

Age : 47 Y : 1 M : 1 D

Referred By Prof. Dr. : وليد عوض

Initial Diagnosis : Right breast upper outer quadrant mass

Nature of Specimen : Block (Labelled as 966288)

Receiving Date : 2025-06-26

Analysis ID : 966289

Gender : Female

Patient ID : 715910

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Technique :

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain.
The sections were treated against:
Estrogen receptors - Progesterone receptors - Her 2 - Ki67

Results :

Sections treated for Estrogen receptors revealed NEGATIVE nuclear staining.
0% of tumor cells show WEAK POSITIVE Staining for progesterone receptors.
Sections treated for HER2 revealed MINIMAL INCOMPLETE FAINT CELL MEMBRANE STAINING IN 3% OF TUMOR CELLS.
60% of Tumour cells are POSITIVE for Ki67.

Conclusion :

Block, TUMOUR CELLS ARE
NEGATIVE FOR ESTROGEN RECEPTORS (SCORE 0 / 8)
POSITIVE FOR PROGESTERONE RECEPTORS (SCORE 3 / 8)
HER 2, SCORE 0, WITH CELL MEMBRANE STAINING [ULTRA LOW]
THE PROLIFERATION INDEX OF Ki67 IS 60%.

Prof. Dr. Shady Elia Anis

Prof. Dr. Elia Anis Ishak

This report is electronically signed, any abrasion or modification would render it void.



عمارة رمسيس - بلوك أ - ميدان رمسيس - الدور السادس و السابع
تليفون : ٢٥٧٤٤٧٤٢ - ٢٥٧٧٣٢٥٣ - ٢٥٧٩٠٩٣٥ - ٠١٢٨٧,٠٥٢١٧

جوسناف
روستني
في مستشفىمبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصريةالهيئة العامة
لصحة
المرأة

09/23/2026

MDT FORM

Name:	داليا فاطم منصور لطيف	MRN:	14106
Age:	48 Y	ID:	27805101600947
Menopausal Sta		Phone:*	27805101600947
NRS SCORE:		Marital Status:	
BMI:		Family History:	
Gender		Reason Of MDT:	
CO Morbidity:		new	
Surgical History:*	na	ECOG Performance Status	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Clinical Data:

R L

BX:	
ER:	
PR:	
HER2:	
KI67:	



TNM

History:

The condition started in 6/2025, by an accidentally discovered rt breast mass...pt sought medical advice, where mammosonography & biopsy revealed IDC ER0/8 PR3/8 Her20 Ki67=60%, received NACT dd ACx4 followed by TXT/Cis x4 with partial response & ?? progression before surgery (1 mth gap before surgery)...

underwent Rt BCS 26/11/2025, revealing ypT2 N0/10... received PPRT and adjuvant Xeloda for 6 mths, ending 16/7/2026... during last cycles of xeloda, pt developed local mass with axillary mass...biopsy revealed IDC ER4/8 PR4/8 Her2 0 Ki-67=80%... seeking our advice for further management.

BRCA wild

Right Side		Left Side	
Q1	Q2	Q3	Q4

Clinical Staging:

Sonomammography:

Biomarker/Molecular

Mets Workup:

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

For:

- 1.PDL1 testing
- 2.Portacath insertion then start Gemzar/Carboplatin with close monitoring of response

If rendered resectable, consider salvage mastectomy.

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د شيماء لاشين	د فاطمه عسوي		

23/9/2026
23/9/2026

about:blank